



UNDANGAN



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Banjarnarum Selatan No. 7 Mondoroko
Singosari – Malang
Telp. (0341) 458679, Fax. (0341) 441874

Malang, 29 Desember 2025

Nomor : 1213/DPM/I-UND/LN/XII/2025
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Tertampr

di Tempat

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan Jadwal Presentasi Mutu RS Prima Husada Group sebagai berikut:

NO	HARI / TANGGAL	PUKUL	JADWAL	TEMPAT
1.	Selasa/ 6 Januari 2026	09.00 WIB	Presentasi Laporan Hasil Perbaikan Mutu IMPRS tahun 2025 (Lengkap beberapa siklus termasuk dampak sekunder/KMKB)	Zoom Meeting
2.	Rabu/ 7 Januari 2026	11.30 WIB	Presentasi pemilihan Indikator Mutu (IMPRS 2026)	
3.	Kamis/ 8 Januari 2026	09.00 WIB	Presentasi Laporan Hasil Survei Budaya Keselamatan RS tahun 2025 Dan RTL	

Demikian undangan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Manajer Mutu dan Pelayanan
PT Disa Prima Medika



Dr. dr. Aslilchah, M.Kes., AFP



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Banjaranum Selatan No. 7 Mondoroko
Singosari – Malang
Telp. (0341) 458679, Fax. (0341) 441874

Lampiran : I (Satu)
Nomor : 1213/DPM/I-UND/LN/XII/2025
Tanggal : 27 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

NO	INSTANSI	NAMA
1.	Komisaris PT Disa Prima Medika	dr. Lowi Krissadi Endari, MARS., C.Ht
2.	PLT Direktur RS Prima Husada Malang	dr. Resti Lestantini, M.Kes
3.	Direktur RS Dharma Husada	dr. Ifft Bagus Apriantono, M.MRS
4.	Direktur RS Prima Husada Sukorejo	Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep
5.	PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Prima Husada Malang	Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb
6.	Kepala Bagian Umum RS Prima Husada Malang	drg. Endy Wira Pradana, MMRS
7.	Kepala Bidang Penunjang RS Prima Husada Malang	Dwi Novianti, Amd.AK., S.Kes
8.	PLT Kepala Bidang Pelayanan RS Prima Husada Sukorejo	Sisca Puspitasari, S.Kep., Ns
9.	Kepala Bidang Penunjang Medis RS Prima Husada Sukorejo	Nur Lallatul Farida, S.Kep., Ns
10.	Kepala Bagian Umum RS Prima Husada Sukorejo	Wulandari
11.	PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Dharma Husada Probolinggo	dr. Dyan Santi Palupi
12.	Mutu RS Prima Husada Malang	Alfia Dian Sukmaningtyas, S.Kep.Ns
13.	Mutu RS Prima Husada Sukorejo	Lidia Puspita Kencana, S.KM
14.	Mutu RS Dharma Husada Probolinggo	Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM

Hormat kami,
Manajer Mutu dan Pelayanan
PT Disa Prima Medika



Dr. dr. Aslilchah, M.Kes., AFP

MATERI





PEMILIHAN INDIKATOR MUTU IMPRS TAHUN 2026

Oleh : Heni Indra Wulansari, S.Kep. Ns., M.Kep







INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN

SKP	JUDUL INDIKATOR
Mengidentifikasi pasien dengan benar	Kepatuhan dalam identifikasi
Meningkatkan komunikasi efektif	Kepatuhan PPA dalam penggunaan SBAR
Meningkatkan keamanan obat – obatan yang diwaspadai	Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert
Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ tindakan invasive	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien
Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan	Kepatuhan kebersihan tangan
Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh	Kepatuhan dalam upaya risiko jatuh

NO	MASALAH	JUMLAH
1	Ketidakpatuhan dalam identifikasi	295 dari 76451
2	Ketidakpatuhan PPA dalam penggunaan SBAR	242 dari 10396
3	Ketidakpatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert	6250 dari 13.000
4	Ketidakpatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien	405 dari 854
5	Ketidakpatuhan kebersihan tangan	1608 dari 8413
6	Ketidakpatuhan dalam upaya risiko jatuh	414 dari 75894

PENGUKURAN DIAGNOSIS KLINIS PRIORITAS

		RAWAT RUMAH SAKIT											
		INDIKATOR											
N O	PENYAKIT	JUMLAH KASUS	MASALAH PALING BANYAK DIRIS	HIGH VOLUME	BIAYA TINGGI (HIGH COST)	PROSES BERESKOR TINGGI(HIGH PROSES)	KETIDAKPUAS AN PASIEN DAN STAF	KEMUDAHAN DALAM PENGURUSAN	KETUNTUAN PEMERINTAH/ PERSARAFAT EKSTERNAL	SESUAI TUJUAN STRATEGIS RUMAH SAKIT	MEMBERI PENGALAMAN PASIEN YANG LEBIH BAIK	SKOR	RANKING
	Bobot		20%	15%	15%	15%	10%	5%	10%	5%	5%	100%	
1	Typhoid fever	1879	20%	15%	15%	15%	2%	5%	2%	1%	5%	68%	4
2	Bronchopneumonia, unspecified	927	12%	15%	8%	9%	2%	5%	10%	3%	4%	66%	5
3	Dengue fever (classical dengue)	646	12%	12%	15%	9%	2%	5%	2%	5%	4%	66%	6
4	Pneumonia, unspecified	622	12%	12%	3%	9%	2%	5%	10%	5%	4%	62%	7
5	Cerebral infarction, unspecified	498	20%	8%	3%	12%	2%	1%	2%	1%	3%	53%	9
6	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	464	12%	9%	9%	12%	2%	5%	2%	3%	3%	57%	8
7	Cerebral infarction due to embolism of cerebral arteries	333	20%	8%	15%	12%	2%	1%	10%	1%	3%	73%	3
8	Benign neoplasm, other specified sites	314	20%	8%	15%	15%	8%	5%	10%	3%	4%	88%	1
9	Viral infection, unspecified	287	12%	8%	3%	8%	2%	1%	2%	1%	4%	37%	10
10	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications	283	20%	8%	15%	15%	8%	5%	2%	3%	3%	77%	2

PERMASALAHAN

NO	DIAGNOSA	MASALAH	INDIKATOR
Benign neoplasm, other specified sites			
1		Selama periode tahun 2025 jumlah kasus pending sebanyak 72 kasus disebabkan karena ukuran tumor dengan PA yang tidak sama akibat staf tidak patuh dalam menulis ukuran tumor	Tingkat kesesuaian ukuran tumor dengan hasil PA
2		Tingginya angka selisih negative antara INACBGS dengan total biaya RS	Kepatuhan PPK/CP Tumor jaringan lunak
Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications			
1		Adanya pasien komplek karena tidak paham terkait tujuan tindakan yang tidak ditutup (tindakan drebridement)	Kepatuhan pengisian Form Discharge planning pada pasien DM sebagai upaya mitigasi complain pasca rawat
2		Tingginya angka selisih negative antara INACBGS dengan total biaya RS	Kepatuhan PPK/CP DM Tipe 2 dengan komplikasi



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA



PARIPURNA

INDIKATOR SESUAI TUJUAN STRATEGIS RUMAH SAKIT

No	Indikator Mutu	STANDART
1	Kepuasan pasien	>80%
2	Presentase pasien complain	<5%

INDIKATOR SESUAI PERBAIKAN SISTEM

No	Indikator Mutu	STANDART
1	Presentase kelengkapan dan ketepatan waktu integrasi E RM ke satu sehat	100%
2	Waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit dan obat racikan < 60 menit	80%

INDIKATOR SESUAI MANAJEMEN RISIKO

NO	INDIKATOR	STANDART
1	Presentase berkas pending klaim	<5%
2	Angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO	0%



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA



PARIPURNA

INDIKATOR SESUAI MANAJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISA RISIKO INHERENT					PENGENDALIAN SUDAH ADA SAKIT (N)	PENGENDALIAN RISIKO (DAMPAK PERILU DISE)
AREA / LOKASI	SEBAB	KODE RISIKO	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	CONCAT (D & P)	SKOR			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Anestesi / center	Karena kurangnya pembinaan dalam pengkondisian diagnosis dan tindakan klaim pasien rawat jalan dan rawat inap	R.1	kurangnya terdapat pending dan audit pada klaim rawat jalan dan rawat inap	sekitar 5% menyebabkan cashflow rumah sakit	kurangnya pemahaman terkait codifikasi diagnosis dan tindakan yang menyebabkan adanya pending dan audit dan serta berdampak pada cashflow rumah sakit	kurangnya pemahaman terkait codifikasi diagnosis dan tindakan yang menyebabkan adanya pending dan audit dan serta berdampak pada cashflow rumah sakit	5	5	55	25	1	
PELAYANAN	Staf tidak membacainengkap / langkah-langkah dalam SPO penggunaan alat	R.2	Kerusakan fisik atau malfungsi pada alat medis.	Kerusakan finansial yang signifikan, terganggunya pelayanan pasien, dan risiko keselamatan pasien	Tenggangannya pelayanan dan kerugian finansial akibat kerusakan alat medis yang disebabkan oleh ketidakpatuhan staf terhadap SPO	Tenggangannya pelayanan dan kerugian finansial akibat kerusakan alat medis yang disebabkan oleh ketidakpatuhan staf terhadap SPO	5	5	55	25	2	



ABSENSI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Sekretariat PT DPM		administrasi		
2	Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep	RSPHSKR	Direktur RSPH Sukorejo		
3		DPM	Kepala Bagian Mutu dan Pelayanan Kesehatan PT Disa Prima Medika	astichah	
4	- LIDIA PUSPITA KENCANA, S.K.M.	RS Prima Husada Sukorejo	Mutu		
5	Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM.	Komite Mutu	PESERTA		
6	Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM.	Komite Mutu	PESERTA		
7	Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM.	Komite Mutu	PESERTA		
8	Ns. Alifia Dian Sukmaningtyas, S. Kep	Sekre Komite PMKP	PESERTA		
9	Ns. Alifia Dian Sukmaningtyas, S. Kep	Sekre Komite PMKP	PESERTA		
10	dr. Resti Lestiantini, M. Kes	RSPHMLG	PLT Direktur RS Prima Husada Malang		

NOTULENSI

HARI / TANGGAL : Selasa, 06 Januari 2026
 PUKUL : 08.30 WIB - Selesai
 AGENDA RAPAT : Penentuan indikator mutu tahun 2026
 Berikut hasil notulen :

PEMIMPIN RAPAT : Dr. dr. Aslichah, M.Kes. AFP., CHAE
 NOTULIS : Lidia Puspita Kencana, S.K.M.
 TEMPAT : Zoom Meeting

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Penentuan Indikator berdasarkan Sasaran Keselamatan Pasien	Berdasarkan data evaluasi, ditemukan beberapa masalah signifikan pada tingkat kepatuhan staf: 1. Identifikasi Pasien Terdapat 295 kasus ketidakpatuhan dalam identifikasi pasien dari total 76.451 pasien yang diobservasi 2. Komunikasi Efektif Ditemukan 242 ketidakpatuhan PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dalam penggunaan teknik komunikasi SBAR dari 10.396 sampel 3. Keamanan Obat: ingkat ketidakpatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan <i>High Alert</i> sangat tinggi, mencapai 6.250 kasus dari 13.000 sampel. 4. Surgical Safety Terdapat 405 ketidakpatuhan dalam penandaan lokasi operasi dari 834 prosedur pembedahan. 5. Pencegahan Infeksi: Ditemukan 1.608 ketidakpatuhan dalam kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>) dari 8.412 kesempatan. 6. Risiko Jatuh:	Penetapan Prioritas RS berdasarkan Keselamatan Pasien: 1. Kepatuhan Identifikasi pasien dengan standar 100% 2. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR dengan standar 100% 3. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert dengan standar 100% 4. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien 100% 5. Kepatuhan Kebersihan Tangan dengan standar $\geq 85\%$ 6. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh dengan standar 100%	Komite Keselamatan Pasien (KKP), Kepala Bidang Pelayanan, dan Kepala Instalasi Farmasi.



NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
		Terdapat 414 ketidakpatuhan dalam upaya pencegahan risiko cedera pasien jatuh dari 75.894 observasi.		
2.	Penentuan Indikator berdasarkan Pelayanan Klinis Prioritas: Kriteria Penilaian (Skoring) Rapat menyepakati penggunaan 9 kriteria pengukuran dengan total bobot 100% untuk menentukan prioritas pelayanan klinis prioritas, yaitu: 1. Masalah Terbanyak (20%) 2. High Volume (15%) 3. High Cost (15%) 4. High Risk (15%) 5. Ketidakpuasan (10%) 6. Kemudahan Pengukuran (5%) 7. Ketentuan Eksternal (10%) 8. Tujuan Strategis (5%) 9. Pengalaman Pasien (5%)	Berdasarkan matriks penilaian terhadap 10 besar penyakit, ditetapkan 2 peringkat teratas sebagai fokus prioritas: 1. Benign Neoplasm (Tumor Jinak) dengan skor total 89% 2. DM Tipe 2 dengan Gangren/Ulcus skor total yakni 77% Ini dikarenakan: 1. Aspek Keluhan dan Risiko Klinis a. DM Tipe 2 dengan Gangren: Mencatatkan 4 komplain keluarga (terkait luka rembes nanah dan respon DPJP). Memiliki risiko tinggi infeksi nosokomial dan sepsis. b. Stroke Infark: Mencatatkan 4 komplain terkait keterlambatan rujukan ke <i>Stroke Unit</i>. 2. Aspek Finansial (High Cost) Ditemukan kerugian (selisih negatif) signifikan pada: a. Tumor Jinak: Defisit sebesar -Rp 1.396.539.554 (Selisih antara Subtotal RS vs INA-CBG). b. DM Tipe 2 dengan Gangren: Defisit sebesar -Rp 931.064.007. 3. Aspek Beban Kerja Staf (Survei 26 Responden): Meskipun skor teknis Tumor Jinak tinggi (3,47), staf memberikan	Penetapan Prioritas RS menetapkan DM Tipe 2 dengan Gangren/Ulcus sebagai fokus evaluasi klinis prioritas.	Komite Medik (KSM Penyakit Dalam & Bedah), Kepala Bidang Pelayanan Medik, dan Kepala Asuransi Center.



NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
		penekanan kualitatif lebih berat pada DM Gangren (3,41) karena: a. Intensitas observasi klinis yang sangat sering. b. Kompleksitas prosedur <i>debridement</i> (koordinasi OK & persiapan alat spesifik). c. Ketidakpastian lama rawat inap (LOS) yang membebani secara fisik dan psikologis. 4. Aspek Regulasi & Strategis: a. DM Tipe 2 merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai KMK No. 1936/2022. b. Perbaikan pada kasus DM Gangren sejalan dengan tujuan strategis RS untuk Efisiensi Biaya (mengurangi defisit anggaran)		
3.	Penentuan Indikator Berdasarkan Tujuan Strategis RS: Berdasarkan visi RS untuk keunggulan layanan dan keberlanjutan finansial, ditetapkan poin-poin strategis berikut: 1. Presentase pasien komplain dengan target 0% 2. Efisiensi Alur IGD (Waktu Tunggu IGD ke Rawat Inap $\leq$ 6 jam)	1. Presentase pasien komplain, : Mengacu pada data dukung tahun 2025 (4 komplain pada kasus DM Gangren dan 4 pada Stroke), rumah sakit berkomitmen mencapai <i>Zero Complaint</i> dengan memperbaiki respon DPJP dan kecepatan pelayanan. 2. Mengurangi penumpukan pasien di IGD dan mempercepat penanganan definitif di ruang rawat inap.	Indikator Mutu Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) RS adalah 1. Presentase pasien komplain dengan target 0% 2. Efisiensi Alur IGD (Waktu Tunggu IGD ke Rawat Inap $\leq$ 6 jam)	Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD), Kepala Bidang Humas/Pemasaran, Kepala MOD, dan Kepala Bidang Yanmed.



NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
4.	Penentuan Indikator Perbaikan Sistem adalah: 1. Kecepatan Layanan Farmasi (Obat Jadi) dengan Target: $\geq 80\%$ pasien mendapatkan obat dalam waktu < 30 menit 2. Kecepatan Layanan Farmasi (Obat Racikan) dengan Target: $\geq 80\%$ pasien mendapatkan obat dalam waktu < 60 menit	1. Masalah pada layanan obat jadi: Meskipun rata-rata tahunan mencapai 82,08%, namun terdapat ketidakkonsistenan kinerja di mana pada 4 periode tertentu (capaian 66,67%, 73,33%, 74,19%, dan 78,52%) hasil berada di bawah standar 80%. Hal ini menunjukkan adanya hambatan situasional yang menyebabkan pelayanan obat jadi sering terlambat 2. Masalah pada layanan obat racikan: capaian indikator waktu tunggu obat racikan secara konsisten gagal memenuhi target (Rata-rata hanya 75,14% dari target 80%). Terdapat tren penurunan yang tajam pada periode-periode tertentu hingga menyentuh angka 68% - 70%, yang mengindikasikan adanya masalah struktural pada proses peracikan, beban kerja, atau ketersediaan fasilitas penunjang.	Indikator Mutu Berdasarkan Perbaikan Sistem yakni: 1. Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat jadi < 30 menit dengan standar : $\geq 80\%$ 2. Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat racikan < 60 menit dengan standar : $\geq 80\%$	Kepala Instalasi Farmasi dan Komite Mutu
5.	Penentuan Indikator mutu manajemen risiko: 1. Presentase Berkas Pending Klaim 2. Persentase Kerusakan Alat Medis Radiologi Akibat Kelalaian Operasional	1. Persentase Berkas Pending Klaim a. Defisit Anggaran: Terdapat selisih negatif yang sangat besar pada diagnosa prioritas, yaitu Tumor Jinak (-Rp 1,39 Miliar) dan DM Tipe 2 dengan Gangren (-Rp 931 Juta) b. Risiko Fatal: Jika berkas klaim pada kasus dengan selisih besar ini mengalami <i>pending</i> (tertunda) atau <i>dispute</i> karena masalah	Indikator Mutu Berdasarkan Manajemen risiko yakni: 1. Presentase Berkas Pending Klaim dengan target 0% 2. Persentase Kerusakan Alat Medis Radiologi Akibat Kelalaian Operasional dengan target 0%	Kepala Bagian Asuransi Center, Kepala Instalasi Radiologi, dan Kepala ATEM



NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
		administrasi, kerugian finansial rumah sakit akan semakin dalam dan mengganggu operasional. 2. Persentase Kerusakan Alat Medis Radiologi Akibat Kelalaian Operasional a. Kelalaian Serah Terima: Kasus Baterai D-AR retak akibat tidak adanya pengecekan bersama dan dokumentasi saat perpindahan alat antar unit (RSPH Malang) b. Kesalahan Operasional (<i>Human Error</i>): Kasus Software CT Scan Corrupt yang diduga kuat akibat user salah melakukan klik/prosedur saat menghidupkan alat. c. Pemaksaan Mekanik Alat: Kasus Sling X-Ray Conventional putus karena user tetap memaksa menggerakkan kolimator yang sudah terasa berat dan menariknya secara kasar		

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



(Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)

Pasuruan, 26 Januari 2026
Notulis

(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

DOKUMENTASI

